

Karta Informacyjna Pacjenta – ID: PAC-001

Wiek: 68 lat | Płeć: Mężczyzna | Data przyjęcia: 21.04.2026

GŁÓWNY POWÓD HOSPITALIZACJI

Pacjent zgłosił się z powodu nasilających się od 3 miesięcy bólów dławicowych o charakterze ucisku za mostkiem, promieniujących do żuchwy i lewego ramienia, pojawiających się po minimalnym wysiłku fizycznym. Towarzyszy temu znaczny spadek tolerancji wysiłku, szybkie męczenie się oraz niedawne incydenty duszności spoczynkowej i omdleń.

WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

- Badanie ultrasonograficzne przezklatkowe (ECHO):** Wykazano obecność masywnych zwapnień na płatkach z odpływem lewej komory. Gradient maksymalny na drodze odpływu wynosi 85 mmHg, a pole ujścia jest krytycznie zwężone (poniżej 0.8 cm^2). Frakcja wyrzutowa (EF) obniżona do 40%.
- Cewnikowanie naczyń wieńcowych (Angiografia):** Stwierdzono krytyczne, wielomiejscowe zwężenia w głównych tętnicach odżywiających główny mięsień pompujący. Gałąź zstępująca przednia (LAD) zwężona w 90%, gałąź okalająca (Cx) w 80%, prawa tętnica (RCA) obwodowo niedrożna.
- Badania laboratoryjne:** Podwyższone stężenie markerów uszkodzenia tkanek niedokrwionych (Troponina T), podwyższony poziom NT-proBNP wskazujący na narastającą niewydolność przeciążeniową.

WNIOSKI Z KONSyliUM

Z uwagi na rozsiany charakter zmian miażdżycowych pacjent nie kwalifikuje się do przezskórnego poszerzania naczyń (angioplastyki). Zmiany degeneracyjne aparatu przepływowego wymagają bezpośredniej, inwazyjnej interwencji i mechanicznej wymiany uszkodzonych struktur.

PLANOWANE POSTĘPOWANIE I KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

- Kwalifikacja:** Pacjent zakwalifikowany do szerokiego otwarcia klatki piersiowej (sternotomii pośrodkowej).
- Wymagania techniczne:** Zabieg wymaga czasowego zatrzymania akcji mięśnia i podłączenia pacjenta do aparatury zastępującej pracę płuc i funkcję tłoczącą krew (KPU).
- Interwencja docelowa:** Pobranie własnych naczyń żylnych pacjenta w celu utworzenia z nich pomostów omijających niedrożne segmenty tętnic (reperfuzja). Jednoczesne wycięcie zwapniałych płatków i implantacja sztucznego, biologicznego mechanizmu przepływowego w miejscu przewężenia.
- Opieka pooperacyjna:** Konieczność intensywnego monitorowania hemodynamicznego, gotowość do wdrożenia mechanicznego wspomaganie pracy układu krążenia, optymalizacja procesu odłączania od respiratora.